



BENE CURATI CUIDADOS

NOSSA PAIXÃO É CUIDAR DE QUEM VOCÊ AMA!

APOSTILA OFICIAL

Curso Profissional de Cuidador

Formação em Home Care, Cuidados Domiciliares e Assistência ao Paciente

*210 horas — 204h teóricas + 6h práticas • 22 módulos • Certificação conforme critérios do curso
CNPJ 60.725.201/0001-88*

Declaração institucional

A BENE CURATI CUIDADOS é responsável pela oferta desta formação profissional. A realização do curso e a obtenção do certificado não estabelecem vínculo empregatício, contratual, societário ou profissional entre o estudante e a Bene Curati Cuidados. Após a conclusão da formação, o profissional poderá buscar oportunidades de atuação de forma livre e independente, observadas sua qualificação, a legislação aplicável e os requisitos de cada contratante.

Carga horária oficial: 210 horas, sendo 204 horas teóricas (módulos 1 a 21) e 6 horas práticas (módulo 22 — manejo obrigatório). O texto de cada aula desta apostila corresponde à leitura disponível no aplicativo do curso.

Sumário

1. Papel do Cuidador — 8h

- Aula 1 — Conceito e papel do cuidador
- Aula 2 — Responsabilidades no domicílio
- Aula 3 — Limites de atuação do cuidador

2. Ética e Humanização — 10h

- Aula 1 — Princípios éticos no cuidado
- Aula 2 — Sigilo, privacidade e imagem
- Aula 3 — Postura profissional e dilemas

3. Anatomia e Fisiologia — 10h

- Aula 1 — Sistemas do corpo úteis ao cuidador
- Aula 2 — Pele, circulação e respiração no idoso
- Aula 3 — Sinais de alerta ligados ao corpo

4. Envelhecimento e Doenças — 12h

- Aula 1 — Envelhecimento e funcionalidade
- Aula 2 — Doenças frequentes no domicílio
- Aula 3 — Piora e quando acionar ajuda

5. Biossegurança — 10h

- Aula 1 — Cadeia de infecção no domicílio
- Aula 2 — Mãos e EPIs
- Aula 3 — Descarte e ambiente seguro

6. Sinais Vitais — 12h

- Aula 1 — O que são sinais vitais
- Aula 2 — Temperatura, pulso e respiração
- Aula 3 — Pressão, dor e emergência

7. Higiene e Banho no Leito — 14h

- Aula 1 — Preparação e intimidade
- Aula 2 — Técnica de banho no leito
- Aula 3 — Higiene íntima e intercorrências

8. Decúbito e Prevenção de LPP — 10h

- Aula 1 — O que é lesão por pressão
- Aula 2 — Mudança de decúbito
- Aula 3 — Umidade e comunicação da lesão

9. Nutrição, Hidratação e Disfagia — 10h

- Aula 1 — Alimentação assistida
- Aula 2 — Hidratação e desidratação
- Aula 3 — Disfagia e engasgo

10. Medicamentos – Limites — 8h

- Aula 1 — O que pode e não pode na medicação
- Aula 2 — Os cinco certos
- Aula 3 — Reações e erros

11. Sondas e Ostomias — 8h

- Aula 1 — Sondas e o papel do cuidador

Aula 2 — Ostomias no cotidiano

Aula 3 — Complicações e limites técnicos

12. Curativos e Pele — 8h

Aula 1 — Prevenção da pele íntegra

Aula 2 — Curativo simples versus complexo

Aula 3 — Como descrever a ferida

13. Mobilização e Prevenção de Quedas — 12h

Aula 1 — Por que o idoso cai

Aula 2 — Transferência cama-cadeira

Aula 3 — Depois da queda

14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM, HAS — 12h

Aula 1 — Alzheimer e rotina

Aula 2 — Parkinson e AVC

Aula 3 — Diabetes e hipertensão

15. Primeiros Socorros — 14h

Aula 1 — Cena segura e pedido de ajuda

Aula 2 — Inconsciência, respiração e engasgo

Aula 3 — Convulsão, queimadura e hemorragia

16. Cuidados Paliativos — 8h

Aula 1 — O que é cuidado paliativo

Aula 2 — Conforto físico

Aula 3 — Família e limite emocional

17. Comunicação e Família — 8h

Aula 1 — Falar com a pessoa cuidada

Aula 2 — Família e conflitos

Aula 3 — Comunicar intercorrência

18. Diário de Bordo — 6h

Aula 1 — Por que registrar

Aula 2 — O que anotar no plantão

Aula 3 — Como escrever e corrigir

19. Autocuidado e Burnout — 8h

Aula 1 — Sinais de burnout

Aula 2 — Pausas e corpo do cuidador

Aula 3 — Rede de apoio

20. Ética e Legislação — 8h

Aula 1 — Direitos da pessoa idosa

Aula 2 — Competências profissionais

Aula 3 — Contrato, registro e responsabilidade

21. Código de Excelência + Técnicas Avançadas — 8h

Aula 1 — Código de excelência Bene Curati

Aula 2 — Revisão das técnicas essenciais

Aula 3 — Preparação para a prova final

22. Manejo prático obrigatório — 6h

Aula prática 1 — Transferência para a cadeira

Aula prática 2 — Trocar lençol com acamados

Aula prática 3 — Vestir roupas em acamados

Aula prática 4 — Mudança de decúbito

Aula prática 5 — Higiene íntima e troca de fralda

1. Papel do Cuidador

Carga horária do módulo: 8 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Conceito e papel do cuidador

Conceito e papel do cuidador

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 1. Papel do Cuidador da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Conceito e papel do cuidador. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Definir o cuidador no home care
- Diferenciar apoio de tratamento

Desenvolvimento

Comece situando o tema conceito e papel do cuidador na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 1. Papel do Cuidador, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- AVDs
- Observação
- Dignidade

Aplicação na prática

Na prática de home care, conceito e papel do cuidador aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a conceito e papel do cuidador. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Conceito e papel do cuidador exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Conceito e papel do cuidador — módulo 1. Papel do Cuidador — aula 1.

Aula 2 — Responsabilidades no domicílio

Responsabilidades no domicílio

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 1. Papel do Cuidador da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Responsabilidades no domicílio. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Cumprir o plantão com rotina
- Entregar informações objetivas

Desenvolvimento

Comece situando o tema responsabilidades no domicílio na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 1. Papel do Cuidador, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Pontualidade
- Observação
- Registro

Aplicação na prática

Na prática de home care, responsabilidades no domicílio aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a responsabilidades no domicílio. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Responsabilidades no domicílio exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Responsabilidades no domicílio — módulo 1. Papel do Cuidador — aula 2.

Aula 3 — Limites de atuação do cuidador

Limites de atuação do cuidador

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 1. Papel do Cuidador da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Limites de atuação do cuidador. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Reconhecer o que é vedado
- Acionar ajuda na hora certa

Desenvolvimento

Comece situando o tema limites de atuação do cuidador na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 1. Papel do Cuidador, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Não prescrever
- Não procedimento invasivo
- Comunicar

Aplicação na prática

Na prática de home care, limites de atuação do cuidador aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a limites de atuação do cuidador. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Limites de atuação do cuidador exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Limites de atuação do cuidador — módulo 1. Papel do Cuidador — aula 3.

2. Ética e Humanização

Carga horária do módulo: 10 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Princípios éticos no cuidado

Princípios éticos no cuidado

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 2. Ética e Humanização da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Princípios éticos no cuidado. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Aplicar respeito e não maleficência

Desenvolvimento

Comece situando o tema princípios éticos no cuidado na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 2. Ética e Humanização, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Autonomia
- Beneficência
- Humanização

Aplicação na prática

Na prática de home care, princípios éticos no cuidado aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a princípios éticos no cuidado. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Princípios éticos no cuidado exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Princípios éticos no cuidado — módulo 2. Ética e Humanização — aula 1.

Aula 2 — Sigilo, privacidade e imagem

Sigilo, privacidade e imagem

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 2. Ética e Humanização da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Sigilo, privacidade e imagem. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Proteger dados e imagens

Desenvolvimento

Comece situando o tema sigilo, privacidade e imagem na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 2. Ética e Humanização, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Sem foto sem autorização
- Discrição
- Celular com critério

Aplicação na prática

Na prática de home care, sigilo, privacidade e imagem aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a sigilo, privacidade e imagem. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Sigilo, privacidade e imagem exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Sigilo, privacidade e imagem — módulo 2. Ética e Humanização — aula 2.

Aula 3 — Postura profissional e dilemas

Postura profissional e dilemas

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 2. Ética e Humanização da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Postura profissional e dilemas. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Manter limite com a família

Desenvolvimento

Comece situando o tema postura profissional e dilemas na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 2. Ética e Humanização, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Linguagem
- Sem fofoca
- Maus-tratos se comunicam

Aplicação na prática

Na prática de home care, postura profissional e dilemas aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a postura profissional e dilemas. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Postura profissional e dilemas exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Postura profissional e dilemas — módulo 2. Ética e Humanização — aula 3.

3. Anatomia e Fisiologia

Carga horária do módulo: 10 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Sistemas do corpo úteis ao cuidador

Sistemas do corpo úteis ao cuidador

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 3. Anatomia e Fisiologia da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Sistemas do corpo úteis ao cuidador. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Ligar órgão ao que se observa

Desenvolvimento

Comece situando o tema sistemas do corpo úteis ao cuidador na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 3. Anatomia e Fisiologia, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Pele
- Cardiorrespiratório
- Nervoso

Aplicação na prática

Na prática de home care, sistemas do corpo úteis ao cuidador aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a sistemas do corpo úteis ao cuidador. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Sistemas do corpo úteis ao cuidador exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Sistemas do corpo úteis ao cuidador — módulo 3. Anatomia e Fisiologia — aula 1.

Aula 2 — Pele, circulação e respiração no idoso

Pele, circulação e respiração no idoso

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 3. Anatomia e Fisiologia da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Pele, circulação e respiração no idoso. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Identificar fragilidade

Desenvolvimento

Comece situando o tema pele, circulação e respiração no idoso na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 3. Anatomia e Fisiologia, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Pele fina
- Edema
- Dispneia

Aplicação na prática

Na prática de home care, pele, circulação e respiração no idoso aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a pele, circulação e respiração no idoso. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Pele, circulação e respiração no idoso exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Pele, circulação e respiração no idoso — módulo 3. Anatomia e Fisiologia — aula 2.

Aula 3 — Sinais de alerta ligados ao corpo

Sinais de alerta ligados ao corpo

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 3. Anatomia e Fisiologia da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Sinais de alerta ligados ao corpo. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Comunicar mudança súbita

Desenvolvimento

Comece situando o tema sinais de alerta ligados ao corpo na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 3. Anatomia e Fisiologia, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Fraqueza de um lado
- Dor no peito
- Parada de xixi

Aplicação na prática

Na prática de home care, sinais de alerta ligados ao corpo aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a sinais de alerta ligados ao corpo. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Sinais de alerta ligados ao corpo exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Sinais de alerta ligados ao corpo — módulo 3. Anatomia e Fisiologia — aula 3.

4. Envelhecimento e Doenças

Carga horária do módulo: 12 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Envelhecimento e funcionalidade

Envelhecimento e funcionalidade

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 4. Envelhecimento e Doenças da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 12 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Envelhecimento e funcionalidade. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Separar idade de dependência

Desenvolvimento

Comece situando o tema envelhecimento e funcionalidade na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 4. Envelhecimento e Doenças, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Função
- Estímulo
- Dignidade

Aplicação na prática

Na prática de home care, envelhecimento e funcionalidade aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a envelhecimento e funcionalidade. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Envelhecimento e funcionalidade exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Envelhecimento e funcionalidade — módulo 4. Envelhecimento e Doenças — aula 1.

Aula 2 — Doenças frequentes no domicílio

Doenças frequentes no domicílio

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 4. Envelhecimento e Doenças da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 12 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Doenças frequentes no domicílio. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Reconhecer descompensação discreta

Desenvolvimento

Comece situando o tema doenças frequentes no domicílio na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 4. Envelhecimento e Doenças, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos pérfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- HAS e diabetes
- ITU
- Artrose

Aplicação na prática

Na prática de home care, doenças frequentes no domicílio aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a doenças frequentes no domicílio. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Doenças frequentes no domicílio exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Doenças frequentes no domicílio — módulo 4. Envelhecimento e Doenças — aula 2.

Aula 3 — Piora e quando acionar ajuda

Piora e quando acionar ajuda

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 4. Envelhecimento e Doenças da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 12 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Piora e quando acionar ajuda. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Diferenciar súbito de gradual

Desenvolvimento

Comece situando o tema piora e quando acionar ajuda na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improvisado.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 4. Envelhecimento e Doenças, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Queda na cabeça
- Falta de ar
- Registrar o aviso

Aplicação na prática

Na prática de home care, piora e quando acionar ajuda aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a piora e quando acionar ajuda. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Piora e quando acionar ajuda exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Piora e quando acionar ajuda — módulo 4. Envelhecimento e Doenças — aula 3.

5. Biossegurança

Carga horária do módulo: 10 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Cadeia de infecção no domicílio

Cadeia de infecção no domicílio

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 5. Biossegurança da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Cadeia de infecção no domicílio. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Quebrar o caminho do microrganismo

Desenvolvimento

Comece situando o tema cadeia de infecção no domicílio na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 5. Biossegurança, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Mãos
- Panos
- Do limpo ao sujo

Aplicação na prática

Na prática de home care, cadeia de infecção no domicílio aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a cadeia de infecção no domicílio. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Cadeia de infecção no domicílio exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Cadeia de infecção no domicílio — módulo 5. Biossegurança — aula 1.

Aula 2 — Mãos e EPIs

Mãos e EPIs

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 5. Biossegurança da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Mãos e EPIs. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Executar os cinco momentos

Desenvolvimento

Comece situando o tema mãos e epis na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 5. Biossegurança, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Água e sabão
- Álcool 70%
- Luva com mão limpa

Aplicação na prática

Na prática de home care, mãos e epis aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a mãos e epis. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Mãos e EPIs exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Mãos e EPIs — módulo 5. Biossegurança — aula 2.

Aula 3 — Descarte e ambiente seguro

Descarte e ambiente seguro

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 5. Biossegurança da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Descarte e ambiente seguro. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Evitar acidente pérfuro

Desenvolvimento

Comece situando o tema descarte e ambiente seguro na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improvisado.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 5. Biossegurança, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Lixo separado
- Não recapar agulha
- Piso seco

Aplicação na prática

Na prática de home care, descarte e ambiente seguro aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a descarte e ambiente seguro. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Descarte e ambiente seguro exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Descarte e ambiente seguro — módulo 5. Biossegurança — aula 3.

6. Sinais Vitais

Carga horária do módulo: 12 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — O que são sinais vitais

O que são sinais vitais

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 6. Sinais Vitais da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 12 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: O que são sinais vitais. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Nomear e registrar com horário

Desenvolvimento

Comece situando o tema o que são sinais vitais na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 6. Sinais Vitais, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Temperatura
- Pulso
- Respiração
- Pressão
- Dor

Aplicação na prática

Na prática de home care, o que são sinais vitais aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a o que são sinais vitais. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: O que são sinais vitais exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: O que são sinais vitais — módulo 6. Sinais Vitais — aula 1.

Aula 2 — Temperatura, pulso e respiração

Temperatura, pulso e respiração

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 6. Sinais Vitais da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 12 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Temperatura, pulso e respiração. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Medir em repouso

Desenvolvimento

Comece situando o tema temperatura, pulso e respiração na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 6. Sinais Vitais, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Evitar pós-banho quente
- Contar 60s se irregular
- Não anunciar a contagem da respiração

Aplicação na prática

Na prática de home care, temperatura, pulso e respiração aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a temperatura, pulso e respiração. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Temperatura, pulso e respiração exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Temperatura, pulso e respiração — módulo 6. Sinais Vitais — aula 2.

Aula 3 — Pressão, dor e emergência

Pressão, dor e emergência

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 6. Sinais Vitais da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 12 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Pressão, dor e emergência. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Juntar número e sintoma

Desenvolvimento

Comece situando o tema pressão, dor e emergência na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 6. Sinais Vitais, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Braço apoiado
- Dor no peito
- Não esperar o fim do plantão

Aplicação na prática

Na prática de home care, pressão, dor e emergência aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a pressão, dor e emergência. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Pressão, dor e emergência exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Pressão, dor e emergência — módulo 6. Sinais Vitais — aula 3.

7. Higiene e Banho no Leito

Carga horária do módulo: 14 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Preparação e intimidade

Preparação e intimidade

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 7. Higiene e Banho no Leito da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 14 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Preparação e intimidade. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Organizar material
- Proteger o corpo

Desenvolvimento

Comece situando o tema preparação e intimidade na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 7. Higiene e Banho no Leito, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Ambiente aquecido
- Explicar o passo
- Cobrir o que não lava

Aplicação na prática

Na prática de home care, preparação e intimidade aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a preparação e intimidade. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Preparação e intimidade exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Preparação e intimidade — módulo 7. Higiene e Banho no Leito — aula 1.

Aula 2 — Técnica de banho no leito

Técnica de banho no leito

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 7. Higiene e Banho no Leito da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 14 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Técnica de banho no leito. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Seguir limpo para sujo

Desenvolvimento

Comece situando o tema técnica de banho no leito na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 7. Higiene e Banho no Leito, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Rosto primeiro
- Íntima por último
- Secar dobras

Aplicação na prática

Na prática de home care, técnica de banho no leito aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a técnica de banho no leito. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Técnica de banho no leito exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Técnica de banho no leito — módulo 7. Higiene e Banho no Leito — aula 2.

Aula 3 — Higiene íntima e intercorrências

Higiene íntima e intercorrências

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 7. Higiene e Banho no Leito da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 14 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Higiene íntima e intercorrências. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Técnica segura

- Registrar recusa ou lesão

Desenvolvimento

Comece situando o tema higiene íntima e intercorrências na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improvisado.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 7. Higiene e Banho no Leito, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Frente para trás
- Não forçar banho
- Avisar ferida nova

Aplicação na prática

Na prática de home care, higiene íntima e intercorrências aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a higiene íntima e intercorrências. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Higiene íntima e intercorrências exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Higiene íntima e intercorrências — módulo 7. Higiene e Banho no Leito — aula 3.

8. Decúbito e Prevenção de LPP

Carga horária do módulo: 10 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — O que é lesão por pressão

O que é lesão por pressão

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 8. Decúbito e Prevenção de LPP da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: O que é lesão por pressão. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Definir LPP
- Pontos de risco

Desenvolvimento

Comece situando o tema o que é lesão por pressão na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 8. Decúbito e Prevenção de LPP, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Sacro
- Calcanhar
- Não massagear vermelhidão

Aplicação na prática

Na prática de home care, o que é lesão por pressão aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a o que é lesão por pressão. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: O que é lesão por pressão exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: O que é lesão por pressão — módulo 8. Decúbito e Prevenção de LPP — aula 1.

Aula 2 — Mudança de decúbito

Mudança de decúbito

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 8. Decúbito e Prevenção de LPP da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Mudança de decúbito. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Virar sem arrastar

Desenvolvimento

Comece situando o tema mudança de decúbito na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 8. Decúbito e Prevenção de LPP, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- A cada 2 horas
- Travesseiro entre joelhos
- Cabeceira sem excesso

Aplicação na prática

Na prática de home care, mudança de decúbito aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a mudança de decúbito. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Mudança de decúbito exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Mudança de decúbito — módulo 8. Decúbito e Prevenção de LPP — aula 2.

Aula 3 — Umidade e comunicação da lesão

Umidade e comunicação da lesão

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 8. Decúbito e Prevenção de LPP da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Umidade e comunicação da lesão. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Manter pele seca

- Descrever sem inventar estágio

Desenvolvimento

Comece situando o tema umidade e comunicação da lesão na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 8. Decúbito e Prevenção de LPP, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Lençol esticado
- Fralda checada
- Cor, tamanho, odor

Aplicação na prática

Na prática de home care, umidade e comunicação da lesão aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a umidade e comunicação da lesão. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Umidade e comunicação da lesão exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Umidade e comunicação da lesão — módulo 8. Decúbito e Prevenção de LPP — aula 3.

9. Nutrição, Hidratação e Disfagia

Carga horária do módulo: 10 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Alimentação assistida

Alimentação assistida

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 9. Nutrição, Hidratação e Disfagia da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Alimentação assistida. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Preparar a refeição segura

Desenvolvimento

Comece situando o tema alimentação assistida na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 9. Nutrição, Hidratação e Disfagia, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Sentado
- Volumes pequenos
- Não apressar

Aplicação na prática

Na prática de home care, alimentação assistida aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a alimentação assistida. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Alimentação assistida exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Alimentação assistida — módulo 9. Nutrição, Hidratação e Disfagia — aula 1.

Aula 2 — Hidratação e desidratação

Hidratação e desidratação

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 9. Nutrição, Hidratação e Disfagia da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Hidratação e desidratação. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Oferecer líquidos com critério

Desenvolvimento

Comece situando o tema hidratação e desidratação na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 9. Nutrição, Hidratação e Disfagia, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Boca seca
- Urina escura
- Goles pequenos

Aplicação na prática

Na prática de home care, hidratação e desidratação aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a hidratação e desidratação. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Hidratação e desidratação exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Hidratação e desidratação — módulo 9. Nutrição, Hidratação e Disfagia — aula 2.

Aula 3 — Disfagia e engasgo

Disfagia e engasgo

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 9. Nutrição, Hidratação e Disfagia da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 10 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Disfagia e engasgo. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Reconhecer e agir

Desenvolvimento

Comece situando o tema disfagia e engasgo na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 9. Nutrição, Hidratação e Disfagia, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Tosse na refeição
- Voz molhada
- Nada na boca se inconsciente

Aplicação na prática

Na prática de home care, disfagia e engasgo aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a disfagia e engasgo. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Disfagia e engasgo exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Disfagia e engasgo — módulo 9. Nutrição, Hidratação e Disfagia — aula 3.

10. Medicamentos – Limites

Carga horária do módulo: 8 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — O que pode e não pode na medicação

O que pode e não pode na medicação

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 10. Medicamentos – Limites da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: O que pode e não pode na medicação. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Auxiliar só a prescrição

Desenvolvimento

Comece situando o tema o que pode e não pode na medicação na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 10. Medicamentos – Limites, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Não muda dose
- Não empresta remédio
- Não esconde sem ordem

Aplicação na prática

Na prática de home care, o que pode e não pode na medicação aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a o que pode e não pode na medicação. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: O que pode e não pode na medicação exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: O que pode e não pode na medicação — módulo 10. Medicamentos – Limites — aula 1.

Aula 2 — Os cinco certos

Os cinco certos

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 10. Medicamentos – Limites da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Os cinco certos. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Conferir antes de oferecer

Desenvolvimento

Comece situando o tema os cinco certos na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 10. Medicamentos – Limites, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Pessoa
- Fármaco
- Dose
- Via
- Hora

Aplicação na prática

Na prática de home care, os cinco certos aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a os cinco certos. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Os cinco certos exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Os cinco certos — módulo 10. Medicamentos – Limites — aula 2.

Aula 3 — Reações e erros

Reações e erros

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 10. Medicamentos – Limites da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Reações e erros. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Agir sem esconder

Desenvolvimento

Comece situando o tema reações e erros na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improvisado.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 10. Medicamentos – Limites, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Urticária
- Falta de ar
- Avisar o erro

Aplicação na prática

Na prática de home care, reações e erros aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a reações e erros. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Reações e erros exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Reações e erros — módulo 10. Medicamentos – Limites — aula 3.

11. Sondas e Ostomias

Carga horária do módulo: 8 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Sondas e o papel do cuidador

Sondas e o papel do cuidador

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 11. Sondas e Ostomias da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Sondas e o papel do cuidador. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Observar sem tracionar

Desenvolvimento

Comece situando o tema sondas e o papel do cuidador na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 11. Sondas e Ostomias, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Fixação
- Cabeceira na dieta
- Não reintroduzir

Aplicação na prática

Na prática de home care, sondas e o papel do cuidador aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a sondas e o papel do cuidador. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Sondas e o papel do cuidador exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Sondas e o papel do cuidador — módulo 11. Sondas e Ostomias — aula 1.

Aula 2 — Ostomias no cotidiano

Ostomias no cotidiano

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 11. Sondas e Ostomias da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Ostomias no cotidiano. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Cuidar da bolsa e da pele

Desenvolvimento

Comece situando o tema ostomias no cotidiano na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 11. Sondas e Ostomias, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Esvaziar a tempo
- Pele periestomal
- Sem tesoura improvisada

Aplicação na prática

Na prática de home care, ostomias no cotidiano aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a ostomias no cotidiano. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Ostomias no cotidiano exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Ostomias no cotidiano — módulo 11. Sondas e Ostomias — aula 2.

Aula 3 — Complicações e limites técnicos

Complicações e limites técnicos

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 11. Sondas e Ostomias da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Complicações e limites técnicos. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Reconhecer emergência do dispositivo

Desenvolvimento

Comece situando o tema complicações e limites técnicos na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 11. Sondas e Ostomias, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Sonda fora
- Sangramento
- Febre

Aplicação na prática

Na prática de home care, complicações e limites técnicos aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a complicações e limites técnicos. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Complicações e limites técnicos exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Complicações e limites técnicos — módulo 11. Sondas e Ostomias — aula 3.

12. Curativos e Pele

Carga horária do módulo: 8 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Prevenção da pele íntegra

Prevenção da pele íntegra

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 12. Curativos e Pele da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Prevenção da pele íntegra. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Hidatar e reduzir fricção

Desenvolvimento

Comece situando o tema prevenção da pele íntegra na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 12. Curativos e Pele, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Dobras secas
- Unhas curtas
- Roupas adequadas

Aplicação na prática

Na prática de home care, prevenção da pele íntegra aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada à prevenção da pele íntegra. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Prevenção da pele íntegra exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Prevenção da pele íntegra — módulo 12. Curativos e Pele — aula 1.

Aula 2 — Curativo simples versus complexo

Curativo simples versus complexo

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 12. Curativos e Pele da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Curativo simples versus complexo. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Saber o limite

Desenvolvimento

Comece situando o tema curativo simples versus complexo na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 12. Curativos e Pele, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Arranhão limpo
- Pus e odor
- Sem pomada caseira

Aplicação na prática

Na prática de home care, curativo simples versus complexo aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a curativo simples versus complexo. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Curativo simples versus complexo exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Curativo simples versus complexo — módulo 12. Curativos e Pele — aula 2.

Aula 3 — Como descrever a ferida

Como descrever a ferida

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 12. Curativos e Pele da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Como descrever a ferida. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Relato útil para a equipe

Desenvolvimento

Comece situando o tema como descrever a ferida na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 12. Curativos e Pele, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos pérfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Local
- Tamanho
- Secreção

Aplicação na prática

Na prática de home care, como descrever a ferida aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a como descrever a ferida. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Como descrever a ferida exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Como descrever a ferida — módulo 12. Curativos e Pele — aula 3.

13. Mobilização e Prevenção de Quedas

Carga horária do módulo: 12 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Por que o idoso cai

Por que o idoso cai

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 13. Mobilização e Prevenção de Quedas da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 12 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Por que o idoso cai. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Mapear risco da casa e do corpo

Desenvolvimento

Comece situando o tema por que o idoso cai na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 13. Mobilização e Prevenção de Quedas, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Tapete
- Tontura ao levantar
- Calçado

Aplicação na prática

Na prática de home care, por que o idoso cai aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a por que o idoso cai. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Por que o idoso cai exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Por que o idoso cai — módulo 13. Mobilização e Prevenção de Quedas — aula 1.

Aula 2 — Transferência cama-cadeira

Transferência cama-cadeira

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 13. Mobilização e Prevenção de Quedas da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 12 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Transferência cama-cadeira. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Proteger a coluna

Desenvolvimento

Comece situando o tema transferência cama-cadeira na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 13. Mobilização e Prevenção de Quedas, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Travar a cadeira
- Flexionar joelhos
- Não puxar o braço

Aplicação na prática

Na prática de home care, transferência cama-cadeira aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a transferência cama-cadeira. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Transferência cama-cadeira exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Transferência cama-cadeira — módulo 13. Mobilização e Prevenção de Quedas — aula 2.

Aula 3 — Depois da queda

Depois da queda

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 13. Mobilização e Prevenção de Quedas da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 12 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Depois da queda. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Avaliar antes de levantar

Desenvolvimento

Comece situando o tema depois da queda na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improvisado.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 13. Mobilização e Prevenção de Quedas, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos pérfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Consciência
- Perna rodada
- Registrar

Aplicação na prática

Na prática de home care, depois da queda aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a depois da queda. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Depois da queda exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Depois da queda — módulo 13. Mobilização e Prevenção de Quedas — aula 3.

14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM, HAS

Carga horária do módulo: 12 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Alzheimer e rotina

Alzheimer e rotina

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM, HAS da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 12 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Alzheimer e rotina. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Frases curtas e ambiente seguro

Desenvolvimento

Comece situando o tema alzheimer e rotina na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM, HAS, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Não discutir o delírio
- Horário estável
- Fogão e porta

Aplicação na prática

Na prática de home care, alzheimer e rotina aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a alzheimer e rotina. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Alzheimer e rotina exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Alzheimer e rotina — módulo 14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM, HAS — aula 1.

Aula 2 — Parkinson e AVC

Parkinson e AVC

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM, HAS da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 12 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Parkinson e AVC. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Dar tempo e reconhecer emergência

Desenvolvimento

Comece situando o tema parkinson e avc na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM, HAS, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Queda e engasgo
- Face-braço-fala
- Hora de início

Aplicação na prática

Na prática de home care, parkinson e avc aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a parkinson e avc. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Parkinson e AVC exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Parkinson e AVC — módulo 14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM, HAS — aula 2.

Aula 3 — Diabetes e hipertensão

Diabetes e hipertensão

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM, HAS da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 12 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Diabetes e hipertensão. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Reconhecer hipoglicemia

Desenvolvimento

Comece situando o tema diabetes e hipertensão na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM, HAS, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Suor frio
- Dor no peito
- Não ajustar insulina

Aplicação na prática

Na prática de home care, diabetes e hipertensão aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a diabetes e hipertensão. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Diabetes e hipertensão exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Diabetes e hipertensão — módulo 14. Alzheimer, Parkinson, AVC, DM, HAS — aula 3.

15. Primeiros Socorros

Carga horária do módulo: 14 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Cena segura e pedido de ajuda

Cena segura e pedido de ajuda

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 15. Primeiros Socorros da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 14 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Cena segura e pedido de ajuda. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Não se acidentar
- Ligar com dados

Desenvolvimento

Comece situando o tema cena segura e pedido de ajuda na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 15. Primeiros Socorros, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Endereço
- Se respira
- O que aconteceu

Aplicação na prática

Na prática de home care, cena segura e pedido de ajuda aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a cena segura e pedido de ajuda. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Cena segura e pedido de ajuda exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Cena segura e pedido de ajuda — módulo 15. Primeiros Socorros — aula 1.

Aula 2 — Inconsciência, respiração e engasgo

Inconsciência, respiração e engasgo

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 15. Primeiros Socorros da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 14 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Inconsciência, respiração e engasgo. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Checar e agir

Desenvolvimento

Comece situando o tema inconsciência, respiração e engasgo na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 15. Primeiros Socorros, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Chamar pelo nome
- Tosse eficaz
- Sem objeto na boca

Aplicação na prática

Na prática de home care, inconsciência, respiração e engasgo aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a inconsciência, respiração e engasgo. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Inconsciência, respiração e engasgo exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Inconsciência, respiração e engasgo — módulo 15. Primeiros Socorros — aula 2.

Aula 3 — Convulsão, queimadura e hemorragia

Convulsão, queimadura e hemorragia

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 15. Primeiros Socorros da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 14 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Convulsão, queimadura e hemorragia. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Proteger e estancar

Desenvolvimento

Comece situando o tema convulsão, queimadura e hemorragia na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 15. Primeiros Socorros, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Cronometrar a crise
- Água na queimadura
- Pressão no sangramento

Aplicação na prática

Na prática de home care, convulsão, queimadura e hemorragia aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a convulsão, queimadura e hemorragia. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Convulsão, queimadura e hemorragia exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Convulsão, queimadura e hemorragia — módulo 15. Primeiros Socorros — aula 3.

16. Cuidados Paliativos

Carga horária do módulo: 8 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — O que é cuidado paliativo

O que é cuidado paliativo

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 16. Cuidados Paliativos da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: O que é cuidado paliativo. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Conforto como meta

Desenvolvimento

Comece situando o tema o que é cuidado paliativo na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 16. Cuidados Paliativos, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Alívio
- Presença
- Não é abandono

Aplicação na prática

Na prática de home care, o que é cuidado paliativo aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a o que é cuidado paliativo. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: O que é cuidado paliativo exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: O que é cuidado paliativo — módulo 16. Cuidados Paliativos — aula 1.

Aula 2 — Conforto físico

Conforto físico

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 16. Cuidados Paliativos da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Conforto físico. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Boca, dor e posição

Desenvolvimento

Comece situando o tema conforto físico na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 16. Cuidados Paliativos, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Gemido se comunica
- Lábios hidratados
- Movimento suave

Aplicação na prática

Na prática de home care, conforto físico aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a conforto físico. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Conforto físico exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Conforto físico — módulo 16. Cuidados Paliativos — aula 2.

Aula 3 — Família e limite emocional

Família e limite emocional

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 16. Cuidados Paliativos da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Família e limite emocional. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Acolher sem prognóstico falso

Desenvolvimento

Comece situando o tema família e limite emocional na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improvisado.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 16. Cuidados Paliativos, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Escuta
- Sem frase pronta
- Pedir revezamento

Aplicação na prática

Na prática de home care, família e limite emocional aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a família e limite emocional. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Família e limite emocional exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Família e limite emocional — módulo 16. Cuidados Paliativos — aula 3.

17. Comunicação e Família

Carga horária do módulo: 8 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Falar com a pessoa cuidada

Falar com a pessoa cuidada

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 17. Comunicação e Família da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Falar com a pessoa cuidada. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Frase curta na altura dos olhos

Desenvolvimento

Comece situando o tema falar com a pessoa cuidada na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 17. Comunicação e Família, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Avisar o toque
- Tempo para responder

Aplicação na prática

Na prática de home care, falar com a pessoa cuidada aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a falar com a pessoa cuidada. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Falar com a pessoa cuidada exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Falar com a pessoa cuidada — módulo 17. Comunicação e Família — aula 1.

Aula 2 — Família e conflitos

Família e conflitos

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 17. Comunicação e Família da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Família e conflitos. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Entregar fato sem escolher lado

Desenvolvimento

Comece situando o tema família e conflitos na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 17. Comunicação e Família, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Um responsável de referência
- Sem fofoca

Aplicação na prática

Na prática de home care, família e conflitos aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a família e conflitos. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Família e conflitos exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Família e conflitos — módulo 17. Comunicação e Família — aula 2.

Aula 3 — Comunicar intercorrência

Comunicar intercorrência

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 17. Comunicação e Família da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Comunicar intercorrência. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Estrutura hora-fato-ação

Desenvolvimento

Comece situando o tema comunicar intercorrência na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 17. Comunicação e Família, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Sem pânico
- Escuta ativa

Aplicação na prática

Na prática de home care, comunicar intercorrência aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a comunicar intercorrência. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Comunicar intercorrência exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Comunicar intercorrência — módulo 17. Comunicação e Família — aula 3.

18. Diário de Bordo

Carga horária do módulo: 6 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Por que registrar

Por que registrar

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 18. Diário de Bordo da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 6 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Por que registrar. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Documento de continuidade

Desenvolvimento

Comece situando o tema por que registrar na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 18. Diário de Bordo, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Memória do plantão
- Proteção

Aplicação na prática

Na prática de home care, por que registrar aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a por que registrar. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Por que registrar exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Por que registrar — módulo 18. Diário de Bordo — aula 1.

Aula 2 — O que anotar no plantão

O que anotar no plantão

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 18. Diário de Bordo da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 6 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: O que anotar no plantão. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Checklist mínimo

Desenvolvimento

Comece situando o tema o que anotar no plantão na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 18. Diário de Bordo, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Alimentação
- Eliminações
- Banho
- Recusa

Aplicação na prática

Na prática de home care, o que anotar no plantão aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a o que anotar no plantão. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: O que anotar no plantão exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: O que anotar no plantão — módulo 18. Diário de Bordo — aula 2.

Aula 3 — Como escrever e corrigir

Como escrever e corrigir

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 18. Diário de Bordo da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 6 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Como escrever e corrigir. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Fato sem gíria

Desenvolvimento

Comece situando o tema como escrever e corrigir na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 18. Diário de Bordo, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Sem rasura ilegal
- Sem WhatsApp pessoal

Aplicação na prática

Na prática de home care, como escrever e corrigir aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a como escrever e corrigir. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Como escrever e corrigir exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Como escrever e corrigir — módulo 18. Diário de Bordo — aula 3.

19. Autocuidado e Burnout

Carga horária do módulo: 8 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Sinais de burnout

Sinais de burnout

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 19. Autocuidado e Burnout da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Sinais de burnout. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Reconhecer cedo

Desenvolvimento

Comece situando o tema sinais de burnout na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 19. Autocuidado e Burnout, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Irritação
- Insônia
- Distanciamento

Aplicação na prática

Na prática de home care, sinais de burnout aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a sinais de burnout. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Sinais de burnout exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Sinais de burnout — módulo 19. Autocuidado e Burnout — aula 1.

Aula 2 — Pausas e corpo do cuidador

Pausas e corpo do cuidador

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 19. Autocuidado e Burnout da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Pausas e corpo do cuidador. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Incluir pausa real

Desenvolvimento

Comece situando o tema pausas e corpo do cuidador na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 19. Autocuidado e Burnout, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Água
- Coluna
- Limite de hora extra

Aplicação na prática

Na prática de home care, pausas e corpo do cuidador aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a pausas e corpo do cuidador. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Pausas e corpo do cuidador exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Pausas e corpo do cuidador — módulo 19. Autocuidado e Burnout — aula 2.

Aula 3 — Rede de apoio

Rede de apoio

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 19. Autocuidado e Burnout da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Rede de apoio. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Pedir revezamento

Desenvolvimento

Comece situando o tema rede de apoio na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 19. Autocuidado e Burnout, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos pérfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Falar com a coordenação
- Buscar ajuda

Aplicação na prática

Na prática de home care, rede de apoio aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a rede de apoio. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Rede de apoio exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Rede de apoio — módulo 19. Autocuidado e Burnout — aula 3.

20. Ética e Legislação

Carga horária do módulo: 8 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Direitos da pessoa idosa

Direitos da pessoa idosa

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 20. Ética e Legislação da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Direitos da pessoa idosa. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Proteger contra violência

Desenvolvimento

Comece situando o tema direitos da pessoa idosa na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 20. Ética e Legislação, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Dignidade
- Alimentação
- Não abandono

Aplicação na prática

Na prática de home care, direitos da pessoa idosa aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a direitos da pessoa idosa. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Direitos da pessoa idosa exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Direitos da pessoa idosa — módulo 20. Ética e Legislação — aula 1.

Aula 2 — Competências profissionais

Competências profissionais

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 20. Ética e Legislação da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Competências profissionais. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Não invadir atribuição privativa

Desenvolvimento

Comece situando o tema competências profissionais na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 20. Ética e Legislação, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Medicina
- Enfermagem
- Cuidador

Aplicação na prática

Na prática de home care, competências profissionais aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a competências profissionais. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Competências profissionais exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Competências profissionais — módulo 20. Ética e Legislação — aula 2.

Aula 3 — Contrato, registro e responsabilidade

Contrato, registro e responsabilidade

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 20. Ética e Legislação da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Contrato, registro e responsabilidade. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Valorizar o documento

Desenvolvimento

Comece situando o tema contrato, registro e responsabilidade na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improvisado.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 20. Ética e Legislação, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Diário
- Função combinada
- Base formativa

Aplicação na prática

Na prática de home care, contrato, registro e responsabilidade aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a contrato, registro e responsabilidade. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Contrato, registro e responsabilidade exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Contrato, registro e responsabilidade — módulo 20. Ética e Legislação — aula 3.

21. Código de Excelência + Técnicas Avançadas

Carga horária do módulo: 8 horas. Conteúdo correspondente às aulas digitais do curso. Os exemplos referem-se à atuação profissional em home care, sem vínculo de emprego com a instituição.

Aula 1 — Código de excelência Bene Curati

Código de excelência Bene Curati

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 21. Código de Excelência + Técnicas Avançadas da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Código de excelência Bene Curati. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Aplicar a conduta institucional

Desenvolvimento

Comece situando o tema código de excelência bene curati na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 21. Código de Excelência + Técnicas Avançadas, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Pontualidade
- Sigilo
- Pedir ajuda

Aplicação na prática

Na prática de home care, código de excelência bene curati aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a código de excelência bene curati. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Código de excelência Bene Curati exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Código de excelência Bene Curati — módulo 21. Código de Excelência + Técnicas Avançadas — aula 1.

Aula 2 — Revisão das técnicas essenciais

Revisão das técnicas essenciais

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 21. Código de Excelência + Técnicas Avançadas da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Revisão das técnicas essenciais. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Encadear o plantão

Desenvolvimento

Comece situando o tema revisão das técnicas essenciais na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improviso.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 21. Código de Excelência + Técnicas Avançadas, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Mãos
- Decúbito
- Alimentação segura

Aplicação na prática

Na prática de home care, revisão das técnicas essenciais aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a revisão das técnicas essenciais. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Revisão das técnicas essenciais exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Revisão das técnicas essenciais — módulo 21. Código de Excelência + Técnicas Avançadas — aula 2.

Aula 3 — Preparação para a prova final

Preparação para a prova final

Introdução

Esta aula pertence ao módulo 21. Código de Excelência + Técnicas Avançadas da Apostila Oficial Ampliada da Bene Curati Cuidados, com carga prevista de 8 horas neste eixo do curso.

O assunto específico agora é: Preparação para a prova final. Leia com calma. O objetivo não é decorar termos de hospital, e sim sair desta tela sabendo o que fazer, o que não fazer e o que escrever no diário de bordo.

No home care a casa é o consultório. Cada decisão do cuidador altera conforto, risco de queda, risco de infecção e a confiança da família. Por isso o texto a seguir aprofunda o tema — e não o resume em três linhas.

A Bene Curati Cuidados forma o cuidador para apoiar atividades de vida diária, observar e comunicar. Nada nesta aula autoriza diagnóstico, prescrição ou procedimento privativo de enfermagem ou medicina.

Objetivos da aula

- Treinar decisão de cuidador

Desenvolvimento

Comece situando o tema preparação para a prova final na rotina real: o que acontece na primeira hora do plantão, o que se observa no corpo da pessoa e o que se fala com quem está na casa.

A apostila trabalha o conteúdo em camadas: conceito, técnica, limite e registro. Pule qualquer uma dessas camadas e o cuidado vira improvisado.

Conceito: dê nome ao que você vê. Se é recusa alimentar, escreva recusa alimentar — não “ele está difícil”. Se é vermelhidão no sacro que não some após alívio, descreva o local e o aspecto.

Técnica: toda ação tem sequência. Mãos, explicar, posicionar, executar, secar ou acomodar, observar reação, anotar. Inverter a ordem aumenta risco.

Limite: pergunte “isso é apoio à vida diária ou é ato clínico?”. Se for ato clínico, o cuidador protege, registra e aciona. Não completa o vazio com criatividade.

Registro: o plantão seguinte só existe se o seu texto for útil. Hora, fato, o que foi feito, o que a pessoa aceitou ou recusou, quem foi avisado.

No módulo 21. Código de Excelência + Técnicas Avançadas, este assunto se conecta com biossegurança, comunicação e ética. Uma falha aqui costuma aparecer depois como queda, lesão, engasgo ou briga familiar.

Observe o ambiente: luz, tapete, temperatura, privacidade, objetos perfuro-cortantes e medicamentos à vista. Ambiente desorganizado é conteúdo desta aula tanto quanto a técnica do corpo.

A pessoa cuidada não é um manequim. Explique o que vai fazer, espere o consentimento possível e proteja a intimidade. Humanização não é discurso — é a toalha cobrindo o que não está sendo lavado.

Quando houver mais de um familiar na casa, defina quem recebe o informe do plantão. Informação solta vira versão distorcida e desgaste do cuidador.

Conceitos fundamentais

- Limites
- Emergências
- 14 de 20

Aplicação na prática

Na prática de home care, preparação para a prova final aparece em situações ordinárias: troca de fralda, refeição, virada no leito, chegada atrasada da família, visita inesperada.

Monte um ritual: ao chegar, lave as mãos, cumprimente a pessoa pelo nome, leia o diário anterior e confirme o plano do dia. Só então inicie procedimentos.

Se a casa não tiver material adequado, não improvise com pano de prato ou remédio da vizinha. Avise o responsável e registre a falta.

Trabalhe em dupla sempre que o peso, a agitação ou a dor tornarem o movimento inseguro. Pedir ajuda é técnica, não fraqueza.

Atenção do cuidador

Atenção do cuidador: mudança súbita (minutos) pede ação imediata. Mudança gradual se comunica no mesmo dia, com fato e horário.

Sinais que nunca esperam o fim do plantão: falta de ar, dor no peito, boca torta, fala embolada, desmaio, sangramento importante, engasgo sem tosse eficaz.

Não fotografe o paciente para “mostrar no grupo” sem regra institucional. Dado de saúde é sigilo.

Não esconda erro de rotina. Erro comunicado cedo reduz dano. Erro escondido vira incidente grave.

Exemplo prático

Exemplo: no meio do plantão surge uma situação ligada a preparação para a prova final. A pessoa está diferente de ontem. O cuidador não inventa causa. Ele descreve o que mudou, protege a pessoa, avisa o responsável e anota.

Se a família pedir “não conta para o outro filho”, o critério é segurança da pessoa cuidada, não o recado da briga familiar.

Resumo da aula

Resumo: Preparação para a prova final exige conceito claro, técnica em sequência, limite honesto e registro objetivo.

Memorize três perguntas: isso protege a pessoa? Isso ultrapassa o meu papel? O que eu escreveria agora no diário?

A frase da instituição — Nossa paixão é cuidar de quem você ama — só se realiza no detalhe deste assunto, não no certificado.

Foco exclusivo desta aula: Preparação para a prova final — módulo 21. Código de Excelência + Técnicas Avançadas — aula 3.

22. Manejo prático obrigatório

Seis horas práticas obrigatórias para concluir o curso. Não pontuam na prova final. Os vídeos correspondentes rodam no aplicativo.

Aula prática 1 — Transferência para a cadeira

Transferência para a cadeira

Introdução

Aula prática obrigatória da formação Bene Curati Cuidados. O vídeo correspondente roda no aplicativo do curso e não pontua na prova final. A conclusão do curso exige assistir e marcar esta aula.

Desenvolvimento

Trave a cadeira, retire o apoio de pés, sente a pessoa na beira da cama com os pés apoiados e explique o movimento. Conte até três. Não puxe pelos braços. Use as pernas, não a lombar.

Atenção

Se a pessoa desabar, conduza ao chão com controle e acione ajuda se houver dor, tontura ou suspeita de fratura.

Aula prática 2 — Trocar lençol com acamados

Trocar lençol com acamados

Introdução

Aula prática obrigatória. Trocar o lençol com a pessoa no leito exige técnica para não arrastar a pele e não provocar queda.

Desenvolvimento

Lateralize a pessoa, enrole o lençol sujo contra o corpo, coloque o lençol limpo no espaço livre e complete o outro lado. Mantenha a intimidade coberta.

Atenção

Não arraste o paciente sobre o tecido. Peça ajuda se o peso ou a dor tornarem o movimento inseguro.

Aula prática 3 — Vestir roupas em acamados

Vestir roupas em acamados

Introdução

Aula prática obrigatória. Vestir alguém acamado protege a dignidade e reduz lesão articular.

Desenvolvimento

Vista primeiro o lado mais comprometido e desvista o lado mais funcional. Não force articulações. Escolha roupa folgada e fácil de abrir.

Atenção

Dor, resistência ou deformidade exigem parar e comunicar a equipe ou o responsável.

Aula prática 4 — Mudança de decúbito

Mudança de decúbito

Introdução

Aula prática obrigatória. O reposicionamento no leito previne lesão por pressão e desconforto.

Desenvolvimento

Alinhe cabeça e tronco. No decúbito lateral, use travesseiro entre os joelhos. Evite arrastar. A referência usual é reposicionar a cada duas horas, salvo orientação da equipe.

Atenção

Vermelhidão que não some após o alívio de pressão deve ser descrita e comunicada.

Aula prática 5 — Higiene íntima e troca de fralda

Higiene íntima e troca de fralda

Introdução

Aula prática obrigatória. A troca de fralda e a higiene íntima protegem a pele e a dignidade da pessoa.

Desenvolvimento

Prepare o material, feche a porta, explique o que vai fazer e cubra o que não está sendo higienizado. Na mulher, a sequência é da frente para trás. Troque luvas se necessário.

Atenção

Registre lesão, odor diferente, recusa ou sangramento. Não improvise material de higiene.

Encerramento

Esta apostila reproduz a leitura oficial das aulas do aplicativo Bene Curati Cuidados. Carga horária: 210 horas (204 teóricas + 6 práticas). A conclusão e o certificado comprovam a formação; não contratam nem vinculam o estudante à empresa.

BENE CURATI CUIDADOS — Nossa paixão é cuidar de quem você ama!